

БЕКТЕМ

Кыргыз Республикасынын
Саламаттык сактоо жана социалдык
өнүктүрүү министрлигинин алдындагы
Дары каражаттары жана медициналык
буюмдар департаментинин
директорунун орун басары
Мамбеталиева Ч.М.

«18» октябрь 2021-ж.



**ДАРЫ КАРАЖАТЫН МЕДИЦИНАДА КОЛДОНУУ БОЮНЧА
НУСКАМА**

МЕМИБЕЛ-Л

Соодадагы аталышы: Мемибел-Л

Эл аралык патенттелбеген же топтук аталышы
Метронидазол + Миконазол + Лидокаин

Дарынын түрү
Кын суппозиторийлери

Курамы

Ар бир кын суппозиторийинде төмөнкүлөр камтылат:

Активдүү заттар:

Метронидазол ВР	750 мг
Миконазол нитраты ВР	200 мг
Лидокаин ВР	100 мг

Көмөкчү заттар: катуу май (Witepsol S-55).

Сүрөттөмөсү

Актан дээрлик ак түскө чейин тунук эмес ок сымал суппозиторийлер.

Фармакодарылык тобу: Гинекологиялык ооруларды дарылоо үчүн антисептиктер жана микробго каршы препараттар. Гинекологиялык ооруларды дарылоо үчүн антисептиктер жана микробго каршы препараттар (кортикостероиддер менен айкалыштарын кошпогондо). Имидазолдон алынгандар.

АТХ коду: G01AF20

Фармакологиялык касиеттери

Фармакодинамикасы

Мемибел-Л кын суппозиторийлеринде метронидазол – бактерияга каршы жана трихомонозго каршы таасир үчүн, миконазол мите козу карынга каршы таасир үчүн, ошондой эле жергиликтүү ооруксуздандыруучу таасир берүүчү лидокаин камтылат.

Метронидазол – бактерияга каршы каражат. Таасир берүү механизми клетка ичиндеги анаэробдук микроорганизмдердин жана жөнөкөйлөрдүн транспорттук протеиндери менен метронидазолдун 5-нитротобун биохимиялык калыбына келтирүүсүндө турат. Калыбына келген метронидазолдун 5-нитротобу микроорганизмдердин клеткаларынын ДНКсы менен алардын нуклеин кислоталарын басаңдатуу менен өз ара таасирлешет, бул микроорганизмдердин өлүшүнө алып келет.

Препарат *Trichomonas vaginalis*, *Gardnerella vaginalis*, *Giardia intestinalis*, *Entamoeba histolytica*, облигаттуу анаэробдук бактериялар: *Bacteroides* spp. (анын ичинде *Bacteroides fragilis*, *Bacteroides distasonis*, *Bacteroides ovatus*, *Bacteroides thetaiotaomicron*, *Bacteroides vulgatus*), *Fusobacterium* spp., *Veillonella* spp.; кээ бир грам оң бактериялар: *Eubacterium* spp., *Clostridium* spp., *Peptococcus* spp., *Peptostreptococcus* spp карата активдүү.

Миконазол — имидазолдон алынган, мите козу карынга каршы препарат болуп эсептелет. Миконазол кеңири чөйрөдө таасирге ээ жана өзгөчө патогендүү мите козу карындарга жана ачыткыларга, анын ичинде *Candida albicans* каршы натыйжалуу. Мындан тышкары, ал *Aspergillus* ssp., *Cryptococcus neoformans*, *Pseudoallescheria boydii* оң жана кээ бир грам оң бактерияларга, анын ичинде стафилококктор жана стрептококкторго каршы натыйжалуу.

Миконазол жана метронидазолду бир убакта кабыл алууда синергиялык же антагонисттик таасирге ээ эмес.

Лидокаин импульстардын пайда болушуна жана өтүшүнө зарыл иондук агымдарды басаңдатуу менен нейрондук мембрананы турукташтырат, аны менен жергиликтүү ооруксуздандыруучу таасир көрсөтөт.

Фармакокинетикасы

Миконазол – кын капталдары аркылуу миконазолдун сиңүүсү абдан аз болуп эсептелет (бир жолку дозасынын болжолдуу 1,4 %), кын суппозиторийлерин кынга киргизүүдө кан плазмасында миконазол аныкталбайт.

Метронидазолду пероралдуу жол менен киргизгенде анын биожеткиликтүүлүгүнө салыштырмалуу жергиликтүү жол менен колдонууда биожеткиликтүүлүгү 20% түзөт. Кан плазмасында метронидазолдун тең салмактуу абалдагы концентрациясы 1,6—2 мг/мл жетет. Метронидазол боордо зат алмашат. Гидроксиметаболит активдүү зат болуп эсептелет. Метронидазолду жарым жартылай бөлүп чыгаруу мезгили 6 саатты түзөт. Дозанын болжолдуу 20% өзгөрбөгөн түрдө заара менен бөлүнүп чыгат.

Лидокаин – таасири 3-5 минутадан кийин башталат. Лидокаин жабыркаган териге жана былжырлуу челге сыртынан сыйпоодо сиңет жана боордо тез зат алмашат. Метаболиттер жана дары препараты өзгөрбөгөн түрдө (куюлган дозасынын 10%) бөйрөк аркылуу бөлүнүп чыгат. Лидокаин күн сайын 3 күн бою кын ичине киргизгенден кийин минималдуу өлчөмдө сиңирилет жана плазмадагы анын деңгээли 0,04-1 мкг/мл түзөт.

Колдонууга көрсөтмө

- *Candida albicans* тарабынан козголгон кын кандидозу;
- анаэробдук бактериялардан жана *Gardnerella vaginalis* тарабынан пайда болгон бактериялык вагинит;
- *Trichomonas vaginalis* тарабынан пайда болгон трихомонаддык вагинит;
- кын аралаш инфекциялары.

Каршы көрсөтмө

- препараттын курамдык бөлүктөрүнө жогору сезгичтик;
- дарылануу убагында же дарылануу бүткөндөн кийин 3 ичинде алкоголь ичкен бейтаптар;
- дарылануу мезгилинде же дарылануу бүткөндөн кийин 2 жума ичинде дисульфирам колдонгон бейтаптар;
- кош бойлуулуктун I үч айлыгы, анын ичинде трихомонаддык вагинити бар кош бойлуулар;
- бала эмизүү мезгили;
- өнөкөт жүрөк жетишсиздиги, жүрөк бөгөөсү, синустук түйүн алсыздыгы синдрому, айкын артериялык гипотония;
- порфирия;
- талма;
- боор функциясынын оор бузулуулары;
- 18 жашка чейинки балдар жана өспүрүмдөр курагы.

Колдонуу жолу жана дозасы

Мемибел-Лди дарыгердин кеңешисиз колдонууга болбойт. Эгерде дарыгер менен башкача дайындалбаса, жатаар алдында 7 күн бою бир кын суппозиторийин жаткан абалда кын ичине терең киргизүү керек. Оору кайталанган учурда же башка ыкмалар менен дарылоодо клиникалык оң динамиканын жоктугунда дарылоо курсун кайталоого болот.

Улгайган курактагы бейтаптар үчүн (65 жаштан жогору): колдонуу жолу жана дозалоосу ушундай эле.

Кын суппозиторийлерин жутууга же башка ар кандай жолдор менен колдонууга болбойт. Препарат менен дарылануу мезгилинде жана дарылануудан кийин бир күндөн кем эмес убакыт ичинде алкогольду ичүүгө тыюу салынат жана жыныстык катнаштан кармануу сунушталат.

Кыйыр таасири

Абдан тез-тез ($\geq 1/10$) – кындан бөлүп чыгаруулар.

Тез-тез ($\geq 1/100$, бирок $< 1/10$) - вагинит, вульвовагинит, жамбаш чарасы жакта ыңгайсыздык;

- баш оору, баш айлануу.

Көп эмес ($\geq 1/1000$, бирок $< 1/100$) – суусоо сезими.

Сейрек ($\geq 1/10\ 000$, бирок $<1/1000$) – аллергиялык реакциялар (тери бөртмөсү, кычышуу); - кындын дүүлүгүүшү, ачышуусу жана кычышуусу; - депрессия.

Абдан сейрек ($<1/10\ 00$) - психоэмоционалдык бузулуулар.

Жыштыгы белгисиз: алсыроо, сезгичтиктин төмөндөшү (уюп калуу, теринин сайгылашуусу) же жок болушу, сезимдин бузулушу, четки нейропатия (препаратты узак кабыл алууда жана дозасынан ашырууда), багытын жоготуу, ажитация, психоз, карышуулар, сүйлөөнүн бузулушу, гиперестезия, гипостезия, летаргия, галлюцинациялар, ысуу сезими, кыймылдын бузулуусу, нервоздуулук, тынчсыздануу, элирүү, кулактын чуулдашы, уйку келүү, сүрөттүн экиден же бүдөмүк көрүнүшү, титирөө, акыл-эсин жоготуу, дүүлүккүчтүк, уйкусуздук, акыл-эстин чаташуусу, алсыроо, талмоорсуу; аритмия, синустук брадикардия, артериялык карышуу, басымдын төмөндөшү, жүрөк-кан тамыр коллапсы, жүрөктүн туурасынан бөгөөсү, васкулярдык шишимик, синустук түйүн алсыздыгы синдрому, дефибрилляциялоочу импульстардын чектик маанисинин көбөйүшү, бетке шыкалуулар; табитин жоготуу, даамдын өзгөрүүсү, ооздо металл даамдануу, ооздун кургашы, окшуу, кусуу, ич катуу, ич өтүү, ичтин оорушу жана карышуусу; жергиликтүү дүүлүгүү, жогору сезгичтик, контакттуу дерматит, анафилактикалык шок; метгемоглобинемия, лейкопения.

Көрсөтүлгөн кыйыр таасирлер өтө сейрек учурларда пайда болот, себеби кын ичине колдонууда метронидазолдун кандагы деңгээли абдан төмөн.

Ашыкча доза

Метронидазол менен ашыкча доза алган учурда төмөнкү симптомдор белгиленет: окшуу, кусуу, ич ооруу, ич өтүү, кычышуу, ооздо металл даамдануу, кыймылдын бузулуусу, сезимдин бузулуусу, карышуулар, лейкопения, зааранын күнүрт түстө болушу.

Миконазолду дозасынан ашырууда төмөнкү симптомдор белгиленет: окшуу, кусуу, тамактын жана ооз көңдөйүнүн сезгениши, баш оору, ич өтүү.

Дарылоо: атайын антидоту жок, оору белгилерин жоготууга багытталган дарылоо сунушталат.

Дарылык өз ара таасири

Төмөндө көрсөтүлгөн дары препараттары менен бир убакта колдонууда метронидазолду сиңүрүүсүнүн натыйжасында дарылык өз ара таасирлешүүнүн төмөнкүдөй түрлөрү белгилениши мүмкүн:

Алкоголь: дисульфирам сымал реакциялар (маанайдын начарлашы, психикалык көңүлсүздүк жана башкалар).

Амиодарон: кардиотоксиндүү таасирлер (ЭКГда - Q-T аралыгынын узарышы, “torsades de pointes” тибиндеги полиморфтуу карынча тахикардиясы, жүрөктүн токтошу).

Пероралдуу антикоагулянттар: антикоагулянттык таасирдин күчөшү (кан агуу өрчүшүнүн жогору коркунучу).

Фенитоин: фенитоин концентрациясынын жогорулашы жана метронидазолдун концентрациясынын төмөндөшү.

Фенобарбитал: метронидазолдун концентрациясынын төмөндөшү.

Дисульфирам: борбордук нерв системасы тарабынан бузулуулар болушу мүмкүн (мисалы,

психотикалык реакциялар).

Циметидин: клиренстин төмөндөшү жана метронидазолдун концентрациясынын жана канда лидокаиндин жогорулашы мүмкүн – анын натыйжасында борбордук нерв системасы жана жүрөк-кан тамыр системасы тарабынан кыйыр таасирлердин айкындуулугунун өрчүү жана күчөө коркунучу.

Литий: литийдин токсиндүү таасиринин күчөө коркунучу.

Астемизол жана терфенадин: метронидазол жана миконазол бул кошулманын зат алмашуусун басаңдатат жана кан плазмасында алардын концентрациясын жогорулатат.

Фторурацил: кан плазмасында фторурацилдин концентрациясынын жана анын токсиндүү таасиринин жогорулашы.

Карбамазетин: кан плазмасында карбамазепиндин концентрациясынын жогорулашы.

Циклоспорин: циклоспориндин токсиндүү таасиринин жогорулашы.

Теофиллин жана прокаинамид: кан плазмасында глюкозанын концентрациясынын жана «боор ферменттеринин» активдүүлүгүнүн жогорулашы.

Миконазол нитратынын сиңүүсүнүн натыйжасында дарылык өз ара таасирлешүүсү мүмкүн.

Аценокумарол, анизиндон, дикумарол, фенитоин, фенпрокумон, варфарин: кан агуу коркунучу.

Астемизол, цизаприд, терфенадин: клиренсинин төмөндөшү жана көрсөтүлгөн препараттардын концентрациялары жогорулашы.

Фенитоин жана фосфенитоин: токсиндүү таасирлер коркунучу (кыймылдын бузулуусу, гиперлексия, нистагм, титирөө).

Фентанил: опиоиддик препараттардын таасиринин узактыгынын жогорулашы (БНС, дем алуунун жабыркашы).

Глимепирид: гипогликемия.

Карбамазетин: карбамазепиндин клиренсинин төмөндөшү.

Оксибутинин: оксибутининдин клиренсинин төмөндөшү, натыйжада кан плазмасында анын концентрациясынын жогорулашы (ооз көңдөйүнүн былжырлуу челинин кургашы, ич катуу, баш оору).

Оксикодон: кан плазмасында оксикодондун концентрациясынын жогорулашы, анын клиренсинин төмөндөшү.

Пимозид: кардиотоксиндүү таасирлер (ЭКГда - Q-T аралыгынын узарышы, “torsades de pointes” тибиндеги полиморфтуу карынча тахикардиясы, жүрөктүн токтошу).

Циклоспорин: токсиндүү таасирдин күчөшү (бөйрөк функциясынын бузулуусу, өттүн акпай калышы, сезимдин бузулушу).

Толтеродин: цитохрома P450 2D6 изоферментинин активдүүлүгү төмөндөгөн бейтаптарда толтеродиндин биожеткиликтүүлүгүнүн жогорулашы.

Триметрексам: токсиндүү таасирдин жогорулашы (чучук заттын жабыркашы, бөйрөк жана боор функцияларынын төмөндөшү, АИЖ жараланган жабыркоолору). *Аритмияга каршы препараттар*: лидокаиндин токсиндүүлүгү жогорулашы мүмкүн.

Пропранолол: лидокаиндин клиренсинин төмөндөшү.

Өзгөчө көрсөтмө

Кын ичине гана колдонуу үчүн.

Мемибел-Л препаратынын кардиотоксиндүү коркунучуна байланыштуу аритмияга каршы препараттар (пимозид, амиодарон жана башкалар) менен бир убакта дайындоо тыкыр текшерүүдөн (анын ичинде ЭКГ, Эхо-КГ, Холтеров мониторингдөөсү ЭКГ) кийин жана бейтап үчүн пайда-коркунуч катышын үзгүлтүксүз баалап турган кардиолог-дарыгердин байкоосу алдында гана мүмкүн.

Мемибел-Л препаратын кыйыр антикоагулянттар менен бир убакта колдонуу зарыл болсо жүргүзүлгөн дарылоонун коркунучун үзгүлтүксүз баалоо жана кандын уюу системасынын көрсөткүчтөрүн көзөмөлдөө керек.

Дарылык өз ара таасирлешүү коркунучуна байланыштуу айкалышкан дарылоону алып жаткан бейтаптарга лабораториялык көрсөткүчтөрүн ошондой эле үзгүлтүксүз көзөмөлдөө керек (кандын жалпы анализи, биохимиялык көрсөткүчтөрү, анын ичинде — глюкозанын концентрациясы, креатинин клиренси, канда «боор» трансаминаздарынын активдүүлүгү), кээ бир учурларда гематолог-дарыгердин жана/же гастроэнтерологдун кеңеши талап кылынышы мүмкүн.

Препараттын чоң дозалары жана узакка системалуу колдонуу четки невропатияны жана карышууну пайда кылышы мүмкүн. Дарылануу мезгилинде, курс бүткөндөн кийин жок дегенде 24-48 саат ичинде дисульфирам сымал реакциялардын болушу мүмкүндүгүнө байланыштуу алкогольду ичүүдөн алыс болуу зарыл.

Системалуу кыйыр таасирлердин пайда болуу жыштыгы абдан төмөн, себеби Мемибел-Л кын суппозиторийлеринде камтылган метронидазолду кын ичине колдонууда кан плазмасындагы анын концентрациясы абдан төмөн (пероралдуу ичкенге салыштырмалуу 2-12%).

Вагиниттерде кындын былжыры сезгениши мүмкүн, демек, биринчи суппозиторийди киргизүүдө кындын ачышуусу жана кычышуусу байкалышы мүмкүн. Бул симптомдор дарылоону улантууда тез жоголот.

Препаратты колдонуу учурунда былжырдын катуу дүүлүгүшү пайда болуусунда дарылоону токтотуп дарыгерге кеңешүүгө кайрылуу керек. Айыз мезгилинде Мемибел-Л препаратын колдонуу сунушталбайт, себеби препараттын натыйжалуулугу төмөндөйт же аны колдонууда кыйынчылыктар жаралат.

Жеке гигиена үчүн башка продукттар (тампондор, чайкануу үчүн каражаттар, спермициддер) дарылануу мезгилинде колдонулбашы керек. Трихомонаддык вагинит диагнозу бар аял бейтаптарга алардын жыныстык өнөгүн бир убакта дарылоону сунуштоо зарыл.

Бөйрөк функциясы бузулууда

Бөйрөк функциясынын төмөндөшү лидокаиндин фармакокинетикасына таасир бербейт, бирок метаболиттердин топтолушун пайда кылышы мүмкүн. Бул өзгөчөлүктөрдү Мемибел-Лди бөйрөк функциясы төмөндөгөн бейтаптарга дайындоодо эске алуу зарыл.

Боор функциясы бузулууда

Боор функциясынын олуттуу бузулууларында метронидазолдун клиренси төмөн болушу мүмкүн.

Метронидазолдун чоң дозалары энцефалопатиянын симптомдорун пайда кылышы мүмкүн

жана ошондуктан боор энцефалопатиясы бар бейтаптарда этияттык менен колдонуу керек. Боор энцефалопатиясы менен жабыркаган бейтаптар үчүн метронидазолдун күнүмдүк дозасы 1/3 чейин азайтылышы керек.

Боор функциясы төмөндөгөн бейтаптарда лидокаиндин жарым жартылай бөлүп чыгаруу мезгили эки же андан көп эсеге көбөйүшү мүмкүн.

Педиатрияда колдонуу

Мемибел-Л кыздыгы бүтүн жана жыныстык жетилүүгө жете элек жаш кыздарга колдонууга болбойт.

Кын суппозиторийинин негизи бойго бүтүрбөөчү кын диафрагмасынын резинасы же латекси менен өз ара таасирлеши мүмкүн, ошондуктан аларды бир убакта колдонуу сунушталбайт.

Унаа каражаттарын башкаруу жана потенциалдуу коркунучтуу механизмдер менен иштөө жөндөмдүүлүгүнө таасиринин өзгөчөлүктөрү

Мемибел-Л автомобилди башкаруу жана механизмдер менен иштөө жөндөмдүүлүгүнө таасир бербейт.

Чыгаруу формасы

Ар бир ПВХ/ПЭ стрипте 7 кын суппозиторийи.

Бир стрип колдонуу боюнча нускамасы менен бирге картон таңгакчада.

Сактоо шарты

Кургак, жарыктан корголгон жерде 25°C дан жогору эмес аба табында сактоо керек.

Балдар жетпеген жерде сактоо керек.

Сактоо мөөнөтү

3 жыл. Жарактуулук мөөнөтү өткөндөн кийин колдонууга болбойт.

Берүү шарты

Дарыгердин рецепти боюнча.

Үчүн өндүрүлдү /Manufactured for

BELINDA LABORATORIES LLP

Astra House, Arklow Road,

London, England SE14 6EB, UK (Улуу Британия)

Өндүрүүчү/Manufactured by

BLISS GVS PHARMA LIMITED

Plot No.11, Dewan Udyog Nagar,

Aliyali, Palghar-401404, Maharashtra State,

India (Индия)

Кыргыз Республикасынын аймагында продукциянын (товардын) сапаты боюнча керектөөчүлөрдөн арыз-доолорду кабыл алуучу уюмдун дареги:

«Aman Pharm» (Аман Фарм) ЖЧК, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары,
Шооруков көчөсү, 36.

Тел: (0312) 560466, E-mail: aman.pharm12@gmail.com